חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשפ"ד–2024*

תיקון סעיף 14

1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1] (בחוק זה – החוק העיקרי), בסעיף 14 –

(1) בכל מקום, במקום "5%" יבוא "5.165%";

(2) בסעיף קטן (ה)(4), אחרי "(ב) עד (ד)" יבוא "ו־(11)";

(3) בסעיף קטן (ו), אחרי "(ב) עד (ה1)" יבוא "או (11)";

(4) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(11) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) ו־(ה1), מעסיק החייב לשלם דמי ביטוח בריאות בעד עובד, עובד החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד עצמו ועובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות לפי אותם סעיפים קטנים, ישלמו על החלק מההכנסה שאינו עולה על הסכום המופחת שנקבע לפי סעיף 341 לחוק הביטוח הלאומי, דמי ביטוח בריאות בשיעור של 3.235%.";

(5) בסעיפים קטנים (ז) ו־(ז1), במקום "(ב) עד (ו)" יבוא "(ב) עד (11)";

(6) בסעיפים קטנים (ח)(1) ו־(ט)(2), במקום "(א) עד (ו)" יבוא "(א) עד (11)".

תחילה

2. תחילתו של חוק זה, ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על דמי ביטוח בריאות הנגבים בעד חודש ינואר 2025 ואילך.

הוראת שעה

3. בתקופה שמיום התחילה ועד יום כ"ט בטבת התשצ"ג (31 בדצמבר 2032), יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 15 יבוא:

"דיווח לכנסת – הוראת שעה

15א. שר הבריאות ידווח לוועדת הבריאות של הכנסת, ב־1 בנובמבר בכל שנה החל משנת 2025, על כל אלה:

(1) התוספת התקציבית לתוכנית הלאומית לבריאות הנפש ולמבחני התמיכה למערכת בריאות הנפש המוצעת בהצעת חוק התקציב השנתי שהונחה באותה שנת כספים, והתוספת התקציבית כאמור שמומשה באותה שנת כספים עד למועד הדיווח, והכול לפי תחומי הוצאה אלה:

(א) הרחבת השירות לטיפול מרפאתי שניתן במערכת הציבורית בקהילה, על ידי הגדלת מספר המטפלים במערכת הציבורית, ומספר המגעים הטיפוליים;

(ב) חיזוק החוסן הקהילתי המקומי;

(ג) יצירת רצף טיפולי וחיזוק חלופות אשפוז;

(ד) שיפור האיכות באשפוז הפסיכיאטרי;

---

* התקבל בכנסת ביום ג' באדר ב' התשפ"ד (13 במרץ 2024) [בישיבה שהחלה ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12 במרץ 2024)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1708, מיום י"ט בשבט התשפ"ד (29 בינואר 2024), עמ' 499.

[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשפ"ג, עמ' 727.